

Rapport de Situation de la 17^{ème} Épidémie de la Maladie à Virus EBOLA /RDC

SitRep N°120/MVEBDB/11/09/2026

Date de rapportage : 11 septembre 2026

Date de publication : 12 septembre 2026

FAITS SAILLANTS (dernières 24h)



Aucune nouvelle zone de santé n'a été touchée au cours des dernières 24 heures, constituant un **signal favorable de stabilisation de l'extension géographique de l'épidémie**, à consolider.

Au total, 91 nouveaux cas confirmés ont été rapportés le 11 septembre 2026, contre 80 la veille (+13,8 %) et 86 le 04 septembre (+5,8 %), traduisant une remontée des notifications qui appelle au maintien d'une vigilance accrue.

La transmission demeure fortement concentrée au Nord-Kivu (50 cas) et en Ituri (33 cas), qui totalisent 91,2 % des nouveaux cas, avec une contribution plus importante du Nord-Kivu au cours des dernières 24 heures. Par ailleurs, 39 décès ont été enregistrés, dont 32 communautaires et 7 intra-CTE, contre 49 décès la veille, soit une baisse de 20,4 %. Cette évolution est encourageante,

CUMUL DES CAS	CUMUL DES DÉCÈS CONFIRMÉS	LETALITE	PATIENTS EN ISOLEMENT/CTE	CUMUL DES GUÉRIS	TAUX DE SUIVI DES CONTACTS (Du Jour)
 7 113	 3 437	 48,3%	 855	 1 692	 87,5 %



Provinces touchées et Zones de santé touchées

Résumé des points clés au cours de dernières 24 heures


7 Provinces touchées
Haut-Uélé, Ituri, Nord-Kivu,
Sud-Kivu, Tshopo, Bas-Uélé,
Sud-Ubangi


62 Zones de santé touchées sur 167 (37,1%)

Au cours des dernières 24 heures, **aucune nouvelle zone de santé n'a été touchée**, constituant un signal favorable de stabilisation de l'extension géographique de l'épidémie, à consolider. Par ailleurs, **21 patients ont été déclarés guéris**, dont 11 en Ituri, 6 au Haut-Uélé et 4 au Nord-Kivu.

Au terme de la journée du **11 septembre 2026, 91 nouveaux cas confirmés** de MVE ont été rapportés, contre **80 la veille, soit une hausse de 13,8 %**. Ces cas ont été enregistrés au Nord-Kivu (50), en Ituri (33), au Haut-Uélé (6), dans la Tshopo (1) et au Bas-Uélé (1). Le **Nord-Kivu concentre à lui seul 54,9 % des nouveaux cas**, tandis que le Nord-Kivu et l'Ituri réunis représentent **91,2 % des cas du jour**, confirmant la forte concentration actuelle de la transmission dans ces deux provinces.

Au total, **39 décès ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures**, dont **32 décès communautaires et 7 décès intra-CTE** (3 en Ituri, 3 au Nord-Kivu et 1 dans la Tshopo). Ce nombre est inférieur aux **49 décès rapportés la veille (-20,4 %)**, constituant une évolution favorable à confirmer. Toutefois, la prédominance des décès communautaires (**82,1 % des décès du jour**) demeure un point majeur de vigilance.

Depuis le début de l'épidémie, la RDC cumule **7 113 cas confirmés et 3 437 décès**, soit une létalité de **48,3 %**. L'Ituri demeure l'épicentre historique et concentre **78,3 % des cas cumulés**, tandis que le Nord-Kivu constitue actuellement le principal contributeur aux nouveaux cas.

La transmission concerne actuellement **six provinces**, à savoir **l'Ituri, le Nord-Kivu, le Haut-Uélé, la Tshopo, le Sud-Kivu et le Bas-Uélé**. Le **cas détecté au Sud-Ubangi est considéré comme un cas importé** et fait l'objet d'investigations et de mesures de santé publique renforcées afin de prévenir toute transmission secondaire ; le Sud-Ubangi n'est donc pas, à ce stade, assimilé à une province avec transmission locale établie.

La RDC compte actuellement 61 zones de santé affectées dans six provinces, auxquelles s'ajoute la zone de santé de Bulu, au Sud-Ubangi, où un cas importé a été détecté, sans transmission locale établie à ce stade. L'Ituri compte 28 zones de santé touchées sur 36, suivie du Nord-Kivu (16/34), de la Tshopo (7/23), du Haut-Uélé (6/13), du Bas-Uélé (3/11) et du Sud-Kivu (1/34). Au total, 62 zones de santé ont rapporté au moins un cas confirmé depuis le début de l'épidémie, dont une au Sud-Ubangi liée à cet événement importé.

Tableau 1. Répartition des cas et décès confirmés par province touchée, au 11 septembre 2026.

Province	Nouveaux cas confirmés(24h)	Tota cas confirmés	Total décès (confirmés)	Létalité	Zones de santé touchées
Ituri	33	5571	2 533	45,5%	28/36 (77,8 %)
Nord-Kivu	50	1232	774	62,8%	16/34 (47,0 %)
Haut-Uélé	6	276	115	41,7%	6/13 (46,1 %)
Tshopo	1	25	10	40,0%	7/23 (30,4 %)
Sud-Kivu	0	3	1	33,3%	1/34 (2,9 %)
Bas-Uélé	1	5	3	60,0%	3/11 (27,3%)
Sud Ubangi	0	1	1	100,0%	1/16 (6,3%)
Total	91	7 113	3 437	48,3%	62/167 (37,1 %)

La transmission reste fortement concentrée au **Nord-Kivu et en Ituri, qui regroupent 91,2 % des nouveaux cas**, avec une prédominance du Nord-Kivu au cours des dernières 24 heures (54,9 %). L'Ituri demeure toutefois l'épicentre historique, concentrant **78,3 % des cas cumulés** et la plus forte proportion de zones de santé touchées (77,8 %). L'absence de nouveau cas au Sud-Kivu constitue un signal favorable à consolider. Le cas enregistré au Sud-Ubangi étant **importé**, cette province doit être considérée séparément des six provinces affectées, avec maintien d'une surveillance renforcée afin de prévenir toute transmission secondaire.

Tableau 2. Répartition des cas et décès confirmés par province et zone de santé, au 11 septembre 2026

Province / Zone de santé	Nombre cumulatif			Situation du jour (24h)			
	Cas (n)	Décès (n)	Létalité	Nouv. Cas	Décès communautaires (Swab+)	Décès confirmés intra-CTE	Total décès confirmés
Ituri	5571	2533	45,5%	33	6	3	9
Adja	11	1	9,1%				0
Aru	8	6	75,0%				0
Ariwara	8	2	25,0%				0
Aungba	12	5	41,7%				0
Bambu	179	39	21,8%	1	0		0
Boga	2	2	100,0%				0
Bunia	1550	487	31,4%	12	2		2
Damas	36	9	25,0%				0
Drodro	15	7	46,7%				0
Fataki	78	30	38,5%				0
Gethy	7	3	42,9%				0
Kambala	2	0	0,0%				0
Kilo	33	12	36,4%				0
Komanda	127	84	66,1%	4	2		2
Lita	256	125	48,8%				0
Logo	13	5	38,5%				0
Lolwa	31	8	25,8%				0
Mahagi	4	1	25,0%				0
Mambasa	17	7	41,2%				0
Mandima	46	24	52,2%	2	0		0
Mangala	310	146	47,1%				0
Mongbwalu	654	296	45,3%	5	1		1
Nia-Nia	232	117	50,4%	3	1		1
Nizi	729	273	37,4%	2	0		0

Nyankunde	125	36	28,8%				0
Rimba	11	4	36,4%				0
Rwampara	1007	349	34,7%	1	0		0
Tchomia	68	25	36,8%	3	0		0
A ventiler *	NA	430	NA			3	3
Nord-Kivu	1232	774	62,8%	50	25	3	28
Beni	208	156	75,0%	9	5	2	7
Biena	15	6	40,0%				0
Butembo	230	152	66,1%	5	2		2
Goma	1	0	0,0%				0
Kalunguta	29	12	41,4%	5	1		1
Katwa	513	330	64,3%	14	10		10
Kayna	1	0	0,0%				
Kyondo	29	18	62,1%	0	0	1	1
Lubero	15	7	46,7%	5	3		3
Mabalako	19	9	47,4%	1	1		1
Manguredjipa	8	3	37,5%				0
Masereka	19	8	42,1%	4	2		2
Musienene	113	59	52,2%	3	1		1
Mutwanga	5	2	40,0%	2	0		0
Oicha	11	7	63,6%				0
Vuhovi	16	5	31,3%	2	0		0
Haut-Uélé	276	115	41,7%	6	1	0	1
Boma Mangbetu	29	14	48,3%				0
Gombari	3	1	33,3%				0
Isiro	96	41	42,7%	1	1	0	1
Pawa	57	25	43,9%	5	0	0	0
Rungu	2	1	50,0%				0
Wamba	89	33	37,1%				0
Tshopo	25	10	40,0%	1	0	1	1
Bafwasende	5	1	20,0%	1	0	1	1
Kabondo	4	1	25,0%				0
Lubunga	1	0	0,0%				0
Makiso-Kisangani	10	5	50,0%				0
Mangobo	3	2	66,7%				0
Tshopo	1	0	0,0%				0
Wanie-Rukula	1	1	100,0%				0
Sud-Kivu	3	1	33,3%	0	0	0	0
Miti-Murhesa	3	1	33,3%				0
Bas-Uélé	5	3	60,0%	1	0	0	0
Buta	1	1	100,00%				0
Viadana	1	0	0,00%				0
Ganga	3	2	66,67%	1	0	0	0
Sud Ubangi	1	1	100,0%	0	0	0	0
Bulu	1	1	100,0%				0
Total	7113	3437	48,3%	91	32	7	39

*Il s'agit des décès confirmés survenus dans les différents CTE de la province qui sont en cours de ventilation pour être classifiés par zone de santé.

NA : Non Applicable.

La transmission reste principalement concentrée au Nord-Kivu et en Ituri (91,2 % des nouveaux cas), avec une prédominance du Nord-Kivu au cours des dernières 24 heures. Les foyers de Katwa, Beni, Bunia, Mongbwalu et Pawa nécessitent une intensification ciblée des interventions. L'absence de nouveau cas au Sud-Kivu et au Sud-Ubangi constitue un signal favorable à consolider, tandis que la forte proportion des décès communautaires (82,1 %) demeure un point majeur de vigilance.

Tableau 3. Situation des alertes notifiées par province, au 11 septembre 2026

DPS	Alertes Reçues		Total alertes	Alertes vérifiées et validées (cas suspect)		Alertes vérifiées et invalidées (non-cas suspect)		Nombre de suspects investigués	Nombre de suspects investigués et transférés au CT/CTE (du jour)
	Vivants	Décédés		Vivants	Décédés	Vivants	Décédés		
Haut-Uélé	14	1	15	12	1	2	0	13	7
Bas-Uélé	21	1	22	5	1	16	0	6	0
Ituri	792	66	858	116	66	534	0	182	91
Nord-Kivu	858	36	894	118	36	623	0	154	97
Sud-Kivu	20	0	20	5	0	9	0	5	4
Sud Ubangi	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Tshopo	109	5	114	7	5	102	0	12	5
Total Général	1 814	109	1 923	263	109	1 286	0	372	204

La surveillance maintient une bonne performance avec **100 % (372/372) des cas suspects investigués**. Le taux de vérification des alertes est estimé à **86,2 % (1 658/1 923)**, nécessitant la poursuite des efforts pour réduire les alertes en attente de vérification. Plus de **9 alertes sur 10 sont rapportées par l'Ituri et le Nord-Kivu**, tandis que l'absence de données du Sud-Ubangi constitue un gap à corriger rapidement afin d'assurer une surveillance renforcée autour du cas importé.

Figure 1. Évolution de cas par date de début des symptômes au cours de 21 derniers jours

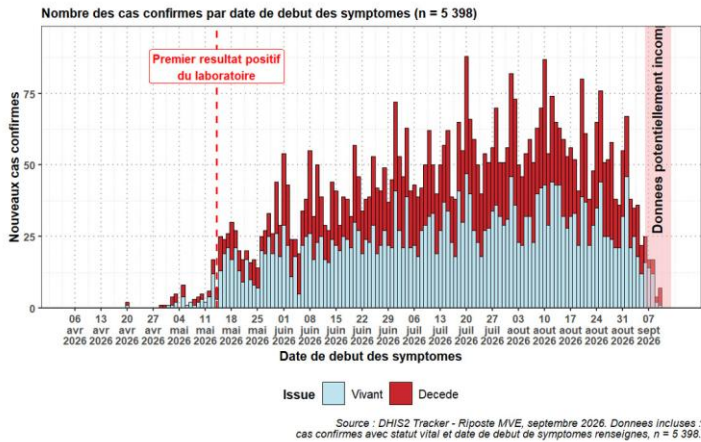
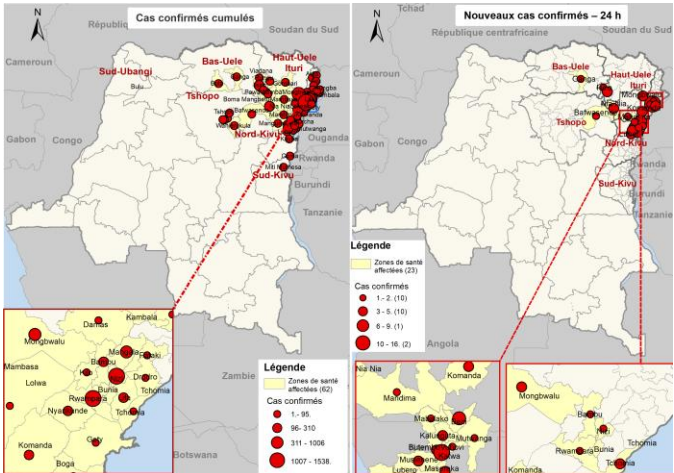


Figure 2. Distribution spatiale des cas confirmés (24h et cumulés) par zone de santé.



1. COORDINATION

1.1. Principales Actions

- Poursuite de la **coordination et du suivi quotidien de la riposte** aux niveaux national et provincial, avec analyse de l'évolution de la situation épidémiologique, des performances des différents piliers et des principaux gaps nécessitant des mesures correctives ;

- Renforcement du **suivi des provinces et zones de santé à transmission active**, particulièrement en Ituri, au Nord-Kivu et au Haut-Uélé, avec une attention portée aux foyers contribuant le plus aux nouveaux cas et aux décès communautaires ;
- Poursuite de la **coordination avec les DPS et les partenaires techniques et financiers** afin d'assurer une meilleure complémentarité des interventions, le suivi des recommandations et l'orientation des ressources vers les besoins prioritaires ;
- Suivi rapproché de la situation au **Sud-Ubangi à la suite de la détection du cas importé dans la ZS de Bulu**, notamment l'avancement des investigations épidémiologiques, le listage et le suivi exhaustif des contacts, la recherche d'éventuels cas secondaires ainsi que la mise en œuvre des mesures de santé publique autour de l'événement ;
- Maintien d'une **coordination renforcée entre le niveau national, la DPS du Sud-Ubangi, la ZS de Bulu et les différents piliers**, afin d'assurer la célérité de la réponse et de prévenir l'installation d'une transmission locale ;
- Poursuite du suivi des **provinces à faible notification ou en accalmie**, afin de consolider les acquis, maintenir une surveillance sensible et détecter précocement toute éventuelle reprise de la transmission.

1.2. Défis majeurs

- Maintenir une coordination différenciée et suffisamment réactive face à la persistance de la transmission dans les principaux foyers actifs, tout en assurant le suivi rapproché du cas importé du Sud-Ubangi afin d'identifier rapidement tout éventuel cas secondaire et d'empêcher l'établissement d'une transmission locale ;
- **La disponibilité encore insuffisante des données de surveillance du Sud-Ubangi**, qui limite l'appréciation en temps réel de la situation autour du cas importé

2. ACTIONS DE RIPOSTE PAR PILIER

2.1.1. Surveillance épidémiologique

2.1.2. Principales Actions

Dans les 6 provinces parmi les 7 actuellement affectées, 1 923 alertes ont été rapportées et 1 658 (86,2%) ont été vérifiées au terme de la journée du 11 septembre 2026. À l'issue de ce processus, 372 alertes ont été validées comme cas suspects. Ces derniers ont tous été investigués (100 %), dont 204 transférés vers les CT/CTE ([Tableau 3](#)).

Parmi les 26 763 en cours de suivi, 23 416 ont été vus, correspondant à une proportion journalière de suivi à **87,5 %** supérieure au seuil de 85 % mais reste similaire à la veille (87,6%) ; 89,2% en Ituri (11 959/13 401), 86,3% au Haut-Uélé (993/ 1 151), 85,9% au Nord-Kivu (10 156/11 823), 80,5 % à la Tshopo (206/256) et 77,3% au Bas-Uélé (102/132). Le listage des contacts autour du premier cas confirmé est en cours dans la province du Sud Ubangi.

2.1.3. Défis

Consolider les performances de la surveillance en améliorant la vérification des alertes (86,2 %) et le suivi des contacts, particulièrement au Bas-Uélé (77,3 %) et dans la Tshopo (80,5 %), tout en assurant au Sud-Ubangi le listage et le suivi exhaustifs des contacts autour du cas importé afin de détecter précocement tout cas secondaire et prévenir une transmission locale.

2.2. Point sur les activités de points de contrôle et points d'entrées (PoE/PoC)

2.2.1. Principales actions

Quatre (4) alertes ont été notifiées aux différents PoE/PoC pour la journée du 11 septembre, dont trois (3) en Ituri et une (1) au Nord-Kivu. **En Ituri**, deux alertes des sujets vivants ont été notifiées aux PoC de Mankoko 2 (ZS de Mambasa) et de Mudzibala (ZS de Bunia), la première invalidée après dépistage secondaire et la seconde isolée, validée puis transférée au CTE de Bunia ; un corps sans vie intercepté au PoC de Zunguluka (ZS de Mambasa) a été swabé avec un résultat négatif ; **Au Nord-Kivu**, une alerte vivante notifiée au PoC de Maboya (ZS de Kalunguta) a été validée après investigation approfondie et référée au centre hospitalier de Tinge.

Tableau 4. Situation indicateurs clés des PoE/PoC par province, en date du 11 Septembre 2026

Indicateurs	Ituri	Nord-Kivu	Sud-Kivu	Tshopo	Haut-Uélé	Global
Complétude des rapports	93,3% (56/60)	100% (19/19)	55,5% (5/9)	100% (18/18)	54,5% (6/11)	88,9% (104/117)
% des PoE/PoC stratégiques fonctionnels	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Nombre de personnes passées aux PoE/PoC	148 004	86 590	7 028	17 910	10 048	269 580
% des voyageurs screenés	97,60%	97,60%	98,30%	99,10%	97,60%	97,70%
% des voyageurs ayant lavé les mains	97,30%	97,60%	98,30%	99,30%	96,10%	97,50%
% des voyageurs sensibilisés	99,60%	97,60%	100,00%	100,00%	100,00%	99,00%
Nombre d'alertes notifiées	3	1	0	0	0	4
Nombre d'alertes vivantes validées (cas suspects)	1	1	0	0	0	2
Nombre de corps sans vie interceptés ce jour	1	0	0	0	0	1
% des cas suspects transférés au CT/CTE	100%	100%	NA	NA	NA	100%
% des corps sans vie swabés/sécurisés	100%	NA	NA	NA	NA	100%
% des cas suspects investigués dans 24 h	100%	100%	NA	NA	NA	100%

2.2.2. Défis

Maintenir les bonnes performances de screening et de prise en charge des alertes aux PoE/PoC, tout en améliorant la complétude des rapports, particulièrement au Haut-Uélé (54,5 %) et au Sud-Kivu (55,5 %), et en renforçant la surveillance des mouvements de populations sur les principaux corridors afin de détecter précocement tout cas suspect et de limiter le risque de propagation interprovinciale de la MVE.

2.3. Laboratoire

2.3.1. Principales actions

- **Ituri : 33 nouveaux résultats positifs** (27 vivants et 6 décès) sur 237 nouveaux échantillons reçus et analysés (**positivité : 13,9%**) ;
- **Nord-Kivu : 50 nouveaux résultats positifs** (25 vivants et 25 décès) sur 237 échantillons analysés (**positivité de 21,1%**) ;
- **Haut-Uélé : 6 nouveaux résultats positifs** (5 vivants et 1 décès) sur 17 échantillons analysés (**positivité : 35,3%**) ;
- **Bas-Uélé : 1 échantillon reçu et testé** (1 vivant), **s'est révélé positif** ;
- **Tshopo : 1 échantillon reçu et testé** (1 vivant), **s'est révélé positif**.

2.3.2. Défis majeurs

Maintenir la disponibilité et la célérité du diagnostic biologique dans toutes les provinces affectées, tout en renforçant la détection et le prélèvement précoces des cas vivants, particulièrement au Nord-Kivu où 50 % des résultats positifs du jour concernent des personnes décédées, et au Haut-Uélé où la positivité demeure élevée (35,3 %). Assurer parallèlement une capacité diagnostique suffisante pour investiguer rapidement toute alerte et rechercher d'éventuels cas secondaires autour du cas importé du Sud-Ubangi.

2.4. Prévention et Contrôle de l'Infection (PCI/EDS)

2.4.1. Principales actions

- **En Ituri**, 26 rings ont été ouverts sur les 71 attendus (36,6 %), 178 ménages décontaminés sur 212 identifiés (84,0 %) et 11 FOSA décontaminées sur 11 (100 %). Quant aux EDS, 82 alertes ont été enregistrées dont 66 EDS réalisés (80,5 %) et 56 corps swabés ;
- **Au Nord-Kivu**, 31 rings ont été ouverts sur les 49 attendus (63,3 %), 10 ménages décontaminés sur 13 identifiés (76,9 %) et 26 FOSA décontaminées sur 32 (81,3 %) ; 10 évaluations FOSA réalisées avec un score moyen de 32,3 % ; évaluation du risque d'exposition : 38/61 à haut risque. Quant aux EDS, 48 alertes ont été enregistrées (dont 24 reports de la veille), 47 EDS réalisés (97,9 %) et 44 corps swabés, 4 échecs à Kalunguta et Vuhovi ;
- **À la Tshopo**, décontamination d'un local de la polyclinique REKAPI (ZS de Kabondo) après le passage du cas confirmé venu du Sud-Ubangi ; 2 rings ouverts à Bafwasende avec décontamination d'une FOSA et de 6 ménages et dotation du kit PCI/EHA à 10 ménages de cas (100 %) ; briefing de 8 agents du laboratoire provincial et de 114 prestataires, suivi et accompagnement de 10 ESS dans 5 zones de santé, 17 DLM suivis et 16 unités de triage installée. Il y a eu 500 litres d'eau approvisionnés à Lubunga. Quant aux EDS, aucune alerte n'a été enregistrée ni aucun EDS réalisé au cours des dernières 24 heures ;
- **Au Haut-Uélé**, 6 rings ont été ouverts sur les 6 attendus (100 %), 14 ménages décontaminés sur 17 identifiés (82,3 %) et 4 FOSA décontaminées sur 4 (100 %), l'ensemble de ces actions étant concentré dans les ZS d'Isiro et de Wamba. Quant aux EDS, 4 alertes ont été enregistrées et 4 EDS réalisés avec swab (100 %) à Isiro (2) et Pawa (2). Au Bas-Uélé, 1 ring a été ouvert sur 1 attendu (100 %) à Ganga ; 1 alerte EDS enregistrée et 1 corps swabé.

2.4.2. Défis

Renforcer la mise en œuvre des rings PCI, particulièrement en Ituri (36,6 %) et au Nord-Kivu (63,3 %), améliorer rapidement les standards PCI dans les FOSA du Nord-Kivu où le score moyen demeure faible (32,3 %), et assurer la décontamination exhaustive des ménages et la réalisation sécurisée des EDS/swabs. Une attention particulière doit également être maintenue sur les structures et lieux fréquentés par le cas importé du Sud-Ubangi, notamment le long de son itinéraire, afin de réduire tout risque de transmission secondaire.

2.5. Prise en charge holistique

2.5.1. Principales actions

- **En Ituri**, 94 nouvelles admissions dans les différentes structures dédiées contre 77 sorties dont 11 guéries. Ainsi, 442 patients sont hospitalisés pour 1007 lits, soit un taux d'occupation de 43,9% ; 406/421 (96 %) patients ont bénéficié de repas chaud ; 12/12 (100 %) enfants sont sous LNPE/SLM au CTE, 5/5 (100 %) à la crèche et 28/28 (100 %) dans la communauté ;
- **Au Nord-Kivu**, 127 nouvelles admissions contre 121 sorties enregistrées dont 4 guéries ; 317 patients sont hospitalisés, soit un taux d'occupation global en sursaturation (139,0%) ; 54/54 malades (100 %), 1/1 accompagnant et 52/52 prestataires de première ligne ont bénéficié de repas chauds ;
- **Au Haut-Uélé**, 10 nouvelles admissions contre 10 sorties (6 guéries). Ainsi, 65 patients sont hospitalisés pour 134 lits, soit un taux d'occupation de 48,5% ; de plus, 49 patients, 54 accompagnants et 28 PPL ont bénéficié de trois repas chauds ;
- **Au Bas-Uélé**, 1 nouvelle admission contre 1 sortie non-cas ; 6 patients demeurent en isolement dont 1 cas confirmé pris en charge à l'HGR de Ganga, et 9 contacts à haut risque sont sous prophylaxie à Buta et à Ganga ;
- **À la Tshopo**, 2 nouvelles admissions ont été enregistrées contre une sortie (décès). Neuf (9) patients sont en isolement pour 31 lits, soit un taux d'occupation de 29,0 % ;
- **Au Sud-Kivu**, Aucune nouvelle admission, 16 cas suspects restent en isolement (taux d'occupation de 64,0 %).

2.5.2. Défis

Résorber en priorité la sursaturation persistante des structures de prise en charge au Nord-Kivu (139,0 %) par l'augmentation et/ou la redistribution rapide des capacités d'isolement et de traitement, tout en maintenant la qualité de la prise en charge holistique dans les autres provinces. Renforcer parallèlement la préparation des capacités de prise en charge au Sud-Ubangi autour du cas importé, afin de garantir l'isolement et la prise en charge immédiate de tout éventuel cas secondaire détecté.

2.6. Vaccination et Prophylaxie Post-exposition

2.6.1. Principales actions

- **À la Tshopo**, 2 153 personnes ont été vaccinées à ce jour sur 11 703 TPL/PPL ciblés (18,4 %), dont 1 378 à Makiso-Kisangani, 312 à Kabondo, 298 à Mangobo, 122 à Tshopo et 43 à Lubunga ; 3 000 doses ont été déployées dans les zones de santé, le solde s'établissant à 847 doses au niveau des zones et à 1 500 doses congelées au dépôt Hub ;
- **En Ituri**, fin de la formation des vaccinateurs et des sensibilisateurs dans le cadre des préparatifs de la vaccination des PPL, dont le démarrage est prévu le 15 septembre 2026 à Bunia ;
- **À la Tshopo**, 119 cas ont reçu le traitement expérimental, dont 14 confirmés et 105 sous prophylaxie post-exposition (68 traitements terminés, 11 interrompus et 26 en cours) ; transfert de 3 contacts à haut risque du CTE vers le centre de transit de l'HGR Makiso-Kisangani et briefing des acteurs CREC sur le fonctionnement du CTE/CT. Au Haut-Uélé, briefing des prestataires sur l'utilisation du traitement spécifique et prophylactique de la MVE et obtention, avec l'équipe de l'INRB, du consentement éclairé des patients positifs en vue de l'adjonction d'une nouvelle molécule.

2.6.2. Défis

Accélérer la vaccination des TPL/PPL dans la Tshopo, où la couverture demeure faible (18,4 %), tout en sécurisant la disponibilité des doses nécessaires et en assurant le démarrage effectif de la vaccination en Ituri le 15 septembre 2026. Renforcer parallèlement le suivi des bénéficiaires de la PEP, notamment des traitements en cours et interrompus, et assurer la disponibilité rapide de la vaccination et de la prophylaxie autour de tout événement à haut risque, y compris le cas importé du Sud-Ubangi et ses contacts éligibles, conformément aux orientations techniques en vigueur.

2.7. Communication sur les risques et engagement communautaire

2.7.1. Principales actions

- **En Ituri**, 14 833 visites à domicile ont touché 50 031 personnes et 746 causeries éducatives ont permis d'atteindre 13 640 personnes ; 46 actions de sensibilisation de masse ont touché 6 553 personnes, 2 débats communautaires 66 personnes et 7 plaidoyers 29 personnes ; 172 alertes communautaires ont été notifiées (dont 20 décès), 7 des 18 feedbacks résolus dans les 48 heures et les 2 incidents communautaires enregistrés résolus à Nizi et Nia-Nia ;
- **Au Nord-Kivu**, 40 648 personnes touchées au cours de 17 506 visites à domicile, 662 personnes atteintes lors de 58 causeries éducatives, 767 lors de 6 actions de communication de masse et 239 lors de 6 briefings ; 241 alertes communautaires notifiées sur 450 attendues (53,5 %), 7 feedbacks résolus sur 12 (58,3 %) et 1 010 personnes engagées sur 4 750 (21,2 %) ;
- **Haut-Uélé** : 3 causeries éducatives ont touché 42 personnes dans la ZS de Pawa et les actions menées autour des derniers cas confirmés ont atteint 45 personnes à Isiro et 31 à Pawa ; 15 alertes de cas suspects et de décès ont été notifiées par les acteurs communautaires à Rungu, Isiro, Pawa, Boma Mangbetu et Wamba, 3 feedbacks résolus dans les 48 heures à Isiro et la préparation du déchargement de 17 vainqueurs de la MVE se poursuit à Pawa, Wamba et Gombari ;
- **À la Tshopo**, 5 actions de sensibilisation de masse ont touché 1 306 personnes dans les 5 zones de santé de la ville de Kisangani, 1 causerie éducative 28 personnes à Isangi et 197 visites à domicile 1 099 personnes ; 2 émissions radiophoniques et 12 spots diffusés dans 6 organes de presse ; 35 alertes communautaires notifiées et toutes résolues ainsi que 3

feedbacks. Au Bas-Uélé, 395 personnes sensibilisées en milieu scolaire (Buta 290 et Monga 105) et briefing des RECO, CAC et CODESA de l'AS de Bambili.

2.7.2. Défis

Renforcer la qualité et l'efficacité de l'engagement communautaire au-delà de la seule couverture des activités, particulièrement au Nord-Kivu, en améliorant la notification des alertes (53,5 %), la résolution rapide des feedbacks (58,3 %) et l'engagement effectif des communautés (21,2 %). Intensifier parallèlement l'écoute communautaire, la gestion des rumeurs et des réticences ainsi que l'implication des leaders locaux, tout en déployant une communication ciblée autour du cas importé du Sud-Ubangi afin de favoriser l'adhésion au listage et au suivi des contacts et de prévenir toute stigmatisation ou transmission secondaire.

2.8. Santé mentale et soutien psychosocial (SMSPS)

2.8.1. Principales actions

- **En Ituri**, 17 personnes parmi les nouveaux cas confirmés et 135 des 163 cas confirmés en cours de suivi (83 %) ont bénéficié d'interventions SMSPS, ainsi que 30 des 94 nouveaux suspects du jour (32 %) et 105 des 159 suspects en cours de suivi (66 %); 77 annonces de résultats réalisées dont 17 positifs, 49 PPL soutenus et 52 ménages accompagnés, 27 enfants et 18 guéris suivis dans la communauté ;
- **Au Nord-Kivu**, 43 personnes parmi les nouveaux cas confirmés et 187 cas confirmés en cours de suivi ont été pris en charge, ainsi que 128 nouveaux suspects et 176 suspects en cours de suivi ; 106 annonces de résultats dont 43 positives, 56 PPL soutenus, 77 ménages accompagnés, 11 des 11 guéris soit 100% suivis ; 507 personnes ont bénéficié de séances de psychoéducation ;
- **À la Tshopo**, 2 cas confirmés en cours de suivi, 5 nouveaux cas suspects et 2 suspects en cours de suivi ont bénéficié d'interventions SMSPS ; 6 contacts ont été soutenus à l'HGR Makiso-Kisangani, 2 accompagnants au CTE et 15 membres des ménages et de la communauté accompagnée ; psychoéducation de 15 femmes à la polyclinique REKAPI et coaching de 2 APS de la ZS de Kabondo ;
- **Au Haut-Uélé**, 6 nouveaux cas confirmés et 24 cas confirmés en cours de suivi, 5 nouveaux cas suspects et 8 suspects en cours de suivi ont bénéficié d'interventions SMSPS, ainsi que 70 accompagnants au CTE et 35 PPL ; 28 résultats de laboratoire ont été annoncés dont 10 positifs et 4 guéris sont sortis, 3 à Isiro et 1 à Wamba, sans kit de déchargement.

2.8.2. Défis

Améliorer la couverture et la continuité des interventions SMSPS pour l'ensemble des cas confirmés, suspects, guéris, familles et PPL, particulièrement en Ituri où la couverture des nouveaux suspects demeure faible (32 %), tout en garantissant la disponibilité des kits de déchargement et l'accompagnement à la réintégration des guéris, notamment au Haut-Uélé. Renforcer également l'appui psychosocial autour du cas importé du Sud-Ubangi, en particulier auprès de la famille et des contacts, afin de favoriser leur adhésion aux mesures de santé publique et de prévenir la stigmatisation.

2.9. Logistique

2.9.1. Principales actions

- **En Ituri**, 15 patients ont été évacués et 14 des 33 transferts organisés ont été réalisés (42,4 %), avec 3 ambulances mobilisées à Bambu, Bunia et Nizi ; au Haut-Uélé, 5 courses d'ambulance ont été réalisées (Isiro 1, Pawa 2 et Boma Mangbetu 2). Au Nord-Kivu, 23 appels reçus pour 23 courses réalisées dont 22 réussies (96 %) et 10 ambulances mobilisées sur les 11 disponibles (91 %) ;
- **À la Tshopo**, 2 appels reçus pour 2 courses réalisées et toutes réussies (100 %), avec 3 ambulances utilisées sur les 3 disponibles ; suivi de la construction du CTE de Bafwasende et de l'isolement de Madula, réception des intrants de laboratoire et poursuite des démarches foncières en vue de la réhabilitation du CTMI avec l'INSP ; colisage des intrants PCI reçus de l'INSP pour déploiement ;

- **Au Bas-Uélé**, aucune donnée logistique n'a été transmise au cours des dernières 24 heures.

1.10.2 Défis majeurs

Améliorer la capacité et la célérité des évacuations sanitaires, particulièrement en Ituri où seulement 42,4 % des transferts organisés ont été réalisés, tout en garantissant la disponibilité opérationnelle des ambulances, des intrants essentiels et des capacités logistiques dans les zones actives. Assurer également la remontée régulière des données logistiques, notamment au Bas-Uélé, et renforcer l'anticipation des besoins au Sud-Ubangi autour du cas importé afin de permettre une évacuation rapide et sécurisée de tout éventuel cas suspect ou secondaire.

2.10. PSEA (Prévention de l'Exploitation et Abus Sexuels)

2.10.1. Principales actions.

- **En Ituri**, 12 membres du personnel de la riposte (7 hommes et 5 femmes) ont reçu le briefing PSEA ; 385 personnes (236 hommes et 149 femmes) ont été sensibilisées dans la communauté et deux partenaires (OMS et Mercy Corps) ont rapporté leurs activités PSEA. Au Bas-Uélé, consultation communautaire de 65 participants à Koteli et mise en place d'un comité de gestion des plaintes de 11 membres dont 9 femmes

2.10.2. Défis

- Couverture encore insuffisante des activités PSEA, seules 13 des 36 zones de santé de l'Ituri (36,1 %) connaissant le mécanisme de signalement ; absence de cartographie des intervenants et refus d'alignement de certains partenaires ; insuffisance de supports de sensibilisation de masse ; manque de kits informatiques et de fournitures de bureau pour le pilier.

2.11. Base des données

2.11.1. Principales actions :

- Poursuite de la **collecte, compilation, consolidation et analyse quotidienne des données** issues des différents piliers et des provinces affectées afin d'alimenter le SitRep national et les outils de suivi de la riposte ;
- Poursuite de la **mise à jour et du contrôle de qualité des bases de données**, avec identification et correction progressive des incohérences, doublons, données manquantes et discordances entre les différentes sources ;
- Poursuite de la **confrontation des données de surveillance, laboratoire, prise en charge et autres bases opérationnelles**, en vue d'améliorer leur cohérence et de disposer de données consolidées pour la prise de décision ;
- Suivi de la **complétude et de la promptitude de la remontée des données** des provinces et zones de santé, avec relance des équipes présentant des données manquantes ou transmises tardivement ;
- Actualisation des **tableaux de bord et produits de visualisation** permettant le suivi de la dynamique épidémiologique, des performances des piliers et des principaux gaps opérationnels ;
- Renforcement de l'accompagnement des équipes provinciales et des zones de santé dans la **saisie, l'analyse et la visualisation des données**, notamment à travers la préparation de la formation des cadres de la DPS Ituri et des zones de santé ciblées sur **DHIS2 Capture**, prévue du **14 au 16 septembre 2026** ;
- Renforcement du suivi de l'intégration et de la remontée des données relatives aux **nouveaux événements épidémiologiques**, notamment celles liées au cas importé du Sud-Ubangi et au suivi de ses contacts.

2.11.2. Défi majeur

Améliorer la qualité, la complétude, la promptitude et la concordance des données entre les différentes sources de la riposte, en renforçant la validation et la déduplication des bases ainsi que les capacités des équipes provinciales et des zones de santé en gestion et analyse des

données, afin de disposer en temps utile d'une base unique, fiable et cohérente pour orienter la prise de décision.

MESSAGES CLES

- Les performances de la surveillance demeurent satisfaisantes, avec **100 % des cas suspects investigués** et un taux de suivi des contacts de **87,5 %**, globalement stable par rapport à la veille (**87,6 %**) et maintenu au-dessus du seuil de **85 %**.
- La transmission demeure **soutenue en Ituri, au Nord-Kivu et au Haut-Uélé**, tandis qu'elle reste **sporadique dans la Tshopo**. Le **Bas-Uélé rapporte un nouveau cas confirmé après plus de 10 jours sans notification de cas**, nécessitant le renforcement des investigations et de la surveillance autour de ce cas.
- Au cours des dernières 24 heures, **91 nouveaux cas confirmés** ont été rapportés. Par ailleurs, **39 décès** ont été enregistrés, dont **32 décès communautaires et 7 décès intra-CTE**, portant le cumul national à **7 113 cas confirmés et 3 437 décès**, soit une létalité de **48,3 %**.
- **L'Ituri demeure l'épicentre de l'épidémie**, concentrant **78,3 % des cas confirmés cumulés**. Toutefois, la dynamique récente est davantage marquée par le **Nord-Kivu**, qui concentre **54,9 % des nouveaux cas du jour**. Ensemble, l'Ituri et le Nord-Kivu représentent **91,2 % des nouveaux cas** rapportés au cours des dernières 24 heures.
- Le **cas importé détecté au Sud-Ubangi** demeure sous surveillance renforcée. Les actions de santé publique se poursuivent autour du cas, notamment l'investigation, le listage et le suivi des contacts ainsi que la recherche active d'éventuels cas secondaires, afin de **prévenir l'établissement d'une transmission locale**.
- Les interventions prioritaires doivent être davantage **ciblées sur les foyers de transmission active**, avec une attention particulière au **Nord-Kivu**, où l'augmentation rapide des capacités d'accueil des **CT/CTE** demeure prioritaire face à leur sursaturation, parallèlement au renforcement de la surveillance, de la PCI, de la prise en charge, de la logistique et de l'engagement communautaire.
- Le renforcement de la **préparation et des capacités de détection et de réponse des provinces situées le long du corridor fluvial** demeure essentiel, notamment à travers la surveillance des mouvements de populations, la fonctionnalité des PoE/PoC, la détection précoce des alertes et la coordination interprovinciale, afin de limiter le risque de propagation de la MVE-B vers de nouvelles zones.

CHRONOLOGIE DES FAITS CLÉS

- Du 24 avril au 15 mai 2026, l'épidémie est passée de la détection des premiers cas suspects à la confirmation biologique du virus Ebola Bundibugyo, conduisant à la déclaration officielle de la 17^e épidémie de Maladie à Virus Ebola en République Démocratique du Congo.
- Entre le 17 et le 18 mai 2026, les autorités nationales, avec l'appui des partenaires, ont renforcé la riposte par la déclaration de l'urgence de santé publique de portée nationale puis continentale, accompagnée de la mobilisation des



TASK FORCE PRESIDENTIELLE EBOLA 17
Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale
Système de gestion de l'incident MVE17

Incident Manager

Professeur Dr AHUKA MUNDEKE Steve

E-mail : steve.ahuka@unikin.ac.cd

Incident Manager Adjoint

Professeur Dr Akilimali Zalagile Pierre

Chargé des opérations

Dr KOMBE NGWAMA John

Equipe de rédaction

Professeur Dr MULANGU KATULUMBA Félix-Médard

Dr KATUSI BISELENGE Jules

Madame MAYELE AFUA Marie

Dr DIUR MANANASHI Floryan

Mr KAMWINA KEBELA John



Contact :

www.sante.gouv.cd

contact@sgiebola17.org

Numéro vert : 151.